

Қайдан шығарылды (Откуда выписан): Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпеннова Н.Д." Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Көшірме жіберілген ұйымның атауы мен мекенжайы (название и адрес организации куда направляется выписка)

ГКП на ПХВ "Ерейментауская РБ" при УЗ Акмолинской области

Науқастың тегі, аты, әкесінің аты (Фамилия, имя, отчество больного): АДЬБЕКОВ ТЕМИРЛАН РУСЛАНОВИЧ

Туған күні (Дата рождения): 21.10.2016

Үйінің мекенжайы (Домашний адрес): ОБЛАСТЬ: Акмолинская, РАЙОН: Ерейментауский, СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ: Тургайский, АУЛ(СЕЛО): Тургай, УЛИЦА: Гагарина, ДОМ: 7

Жұмыс орны мен кәсібі (Место работы и род занятий): Ясли сад "Бөбекжай Әмина" младшая группа

Ауруханаға түскен күні (Дата госпитализации): 11.08.2021 16:25

Ауруханадан шыққан күні (Дата выписки): 25.08.2021 17:00

Сопутствующий диагноз:

Заключительный диагноз: Q76.3Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости

Врожденный сколиоз грудного позвоночника на фоне нарушение формирования позвоночника. Клиновидный Th9 позвонка. Реберный горб слева. Состояние после коррекции сколиоза с частичной экстирпацией полупозвонка Th9 от 22.07.2019

Осложнения:

Расшифровка осложнений:

Сопутствующие заболевания:

Расшифровка сопутствующих заболеваний:

Жалобы при поступлении: на наличие деформации позвоночника, на быструю утомляемость и спотыкание при ходьбе.

Анамнез заболевания: Со слов мамы, ребенок более с рождения. Деформацию заметили в возрасте 1 года. После обследования выявлено врожденное аномалия развития позвоночника. Не лечился. В связи с чем 07.06.2019 проконсультирован в НИИТО, ортопедом-вертебрологом Абдалиевым С.С., рекомендовано госпитализация в плановом порядке через портал госпитализации, на оперативное лечение. 22.07.2019 Коррекция деформации позвоночника эндокорректором. Частичная экстерпация Th9 полупозвонка. Задний спондилодез. Послеоперационный период без особенностей. Данная госпитализация для этапного оперативного лечения.

Анамнез жизни: Болезнь Боткина, туберкулез, вен. заболевания отрицает. Со слов на Д-учете у специалистов состоит по поводу основного заболевания.

Аллергоанамнез: Аллергологический анамнез – со слов не отягощен.

Эпидемиологическое окружение чистое.

Объективное состояние при поступлении: Общее состояние удовлетворительное. Нормального питания. Кожные покровы, видимые слизистые физиологической окраски, чистые. Дыхание прослушивается по всем полям, везикулярное, хрипов нет. ЧДД = 19 в', перкуторно – легочный звук. Тоны сердца приглушены. Пульс ритмичный 100 ударов в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. Язык чистый, влажный. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Симптом поколачивания отрицателен с обеих сторон. Физиологические опрвления в норме. Neurostatus: Контактен. Адекватен. Ориентирован. Зрачки OD=OS, фотореакция живая. Менингеальных знаков нет. функции тазовых органов не нарушены. Нарушения чувствительности нет.

Статус: При осмотре передвигается самостоятельно, без дополнительных средств опоры. Во фронтальной плоскости определяется деформация верхнегрудном отделе позвоночника с выпуклостью влево. Также определяется асимметрия лопаток, надплечий. Положителен симптом Адамса. Сагитальный баланс сохранен. Старый послеоперационный рубец, состоятелен, без признаков воспаления. При пальпации незначительная болезненность грудном отделе позвоночника, пальпируются концы металлоконструкции.. Сосудистых и неврологических нарушений нет.

Инструментальные методы исследования: ЭКГ от 21.07.2021 ритм синусовый, правильный с ЧСС 81 в мин, вертикальная ЭОС.

Рентген. 12.08.2021 11:54. На спондилограммах грудопоясничного отдела в 2-х проекциях определяется состояние после коррекции сколиотической деформации грудопоясничного отдела позвоночника на фоне нарушения формирования тел нижних грудных позвонков левосторонним эндокорректором, фиксирован на уровне Th8-Th12 позвонков. Продольная ось грудопоясничного отдела позвоночника отклонена влево во фронтальной плоскости с вершиной на уровне Th10-Th12 позвонков 25°. Кифоз грудного отдела позвоночника 52°.

Доза облучения: ;
На контрольной рентгенограмме грудопоясничного отдела позвоночника в 2х проекциях от 20.08.2021 определяется состояние после оперативного лечения, дополнительно установлен эндокорректор справа, отмечается уменьшение деформации.

Лабораторно-диагностические исследования: Вич от 16.08.2021 №100000000493 -отрицательно.

ПЦР на Covid 19 от 11.08.2021-отриц.

ОАК от 10.08.2021 гемоглобин 140, лейкоциты 6,1, СОЭ10, эритроциты 4,2, тромбоциты 222.

Коагулограмма от 10.08.2021 МНО 1,04, ПТИ 79,4, АЧТВ 21,2.

Микрореакция от 10.08.2021 №20-отриц.

Биохимия крови от 10.08.2021 белок 68, глюкоза 3,9, АЛТ 0,03, билирубин 13,2 тимоловая проба 2,6.

ОАМ от 10.08.2021 с/желт, прозрачен, белок отр, лейкоциты ед., эпит. плоский 2-4 в п/з.

Гепатиты от 14.07.2021 №0078946207-отриц.

ЛИС Антигела (12.08.2021 13:41):

Антиэритроцитарные антигела отрицательный ;

ЛИС Группа крови и Резус-фактор(12.08.2021 13:41):

Группа крови АВ(IV) четвертая ; Резус-фактор положительный ;

ЛИС Общий анализ крови сокращенный(18.08.2021 07:01):

Лейкоциты $12,70 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты $4,14 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин $123,0 \text{ г/л}$; Гематокрит $33,00 \%$; Средний объем эритроцита $79,7 \text{ фл}$; Среднее содержание гемоглобина в эритроците $29,7 \text{ пг}$; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците $37,3 \text{ г/л}$; Тромбоциты $232,0 \cdot 10^9/\text{л}$; Средний объем тромбоцита $8,7 \text{ фл}$; Соотношение крупных клеток тромбоцитов $16,80 \%$; Тромбоцитоз $0,200 \%$; SD $37,9 \text{ фл}$; Анизоцитоз тромбоцитов $9,9 \text{ фл}$; CV $13,70 \%$;

ЛИС Общий анализ крови сокращенный(19.08.2021 08:26):

Лейкоциты $9,68 \cdot 10^9/\text{л}$; Эритроциты $4,08 \cdot 10^{12}/\text{л}$; Гемоглобин $119,0 \text{ г/л}$; Гематокрит $33,00 \%$; Средний объем эритроцита $80,9 \text{ фл}$; Среднее содержание гемоглобина в эритроците $29,2 \text{ пг}$; Средняя концентрация гемоглобина в эритроците $36,1 \text{ г/л}$; Тромбоциты $200,0 \cdot 10^9/\text{л}$; Средний объем тромбоцита $8,0 \text{ фл}$; Соотношение крупных клеток тромбоцитов $12,20 \%$; Тромбоцитоз $0,160 \%$; SD $40,0 \text{ фл}$; Анизоцитоз тромбоцитов $9,6 \text{ фл}$; CV $14,10 \%$;

ОАК от 20.08.2021 гемоглобин 134 , эритроциты $4,95$, тромбоциты 230 , лейкоциты $6,06$, СОЭ 44 .

Биохимия крови от 20.08.2021 АЛТ $27,25$, АСТ $68,40$, Билирубин $12,0$, Глюкоза $4,51$, Креатинин 30 , Мочевина $3,45$, Общий белок $78,45$

Коагулограмма от 20.08.2021 ПВ13,8, ПТИ $1,00$, МНО $0,96$, Фибриноген $5,01$.

Консультации специалистов: Педиатр 10.08.2021 -эпид. окружение чистое.

Стоматолог 10.08.2021- без патологии.

ЛОР 10.08.2021-здоров. 19-08-2021 Реабилитолог Диагноз: Состояние после: Домонтаж эндокорректора справа, дополнительная коррекция деформации. Задний спондилодез. Реабилитация 1-го этапа. Реабилитационный диагноз по МКФ: B280.2 D230.2 шрм 2 Реабилитационный потенциал средний. Рекомендации: 1. Дыхательная гимнастика на после операционный период №5

2. Ингаляция с амбро №3

3. Магнитотерапия на послеоперационную рану №5

Операции: 81.052 СПОНДИЛОДЕЗ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКОВ, ЗАДНИЙ ДОСТУП, С ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИЕЙ ЭНДОКОРРЕКТОРАМИ Домонтаж эндокорректора справа, дополнительная коррекция деформации.

Задний спондилодез 17.08.2021

Благоприятный

Полученное лечение: промедол $2 \%-0,5 \text{ в/в (в/в) № - 2}$

промедол $2 \%- 0,5 \text{ мл в/м (в/м) № - 2}$

Цефазолин $1\text{г. Кол-во:}0,3 \text{ (в/в) № - 2}$

Анальгин $50\% 2\text{мл. Кол-во:}1,0 \text{ (в/в) + Димедрол } 1\% 1 \text{ мл. Кол-во:}1,0 \text{ (в/в) № - 3}$

Анальгин $50\% 2\text{мл. Кол-во:}1,0 \text{ (в/м) + Димедрол } 1\% 1 \text{ мл. Кол-во:}1,0 \text{ (в/м) № - 4}$

Натрия хлорид раствор для инфузий $0,9\% 200\text{мл. Кол-во:}1,0 \text{ (в/в капельно) + Цефазолин } 1\text{г. Кол-во:}1,0 \text{ (в/в капельно) № - 4}$

Цефазолин $1\text{г. Кол-во:}1,0 \text{ (п/к) + Новокаин } 0,5\% \text{ по } 5 \text{ мл. Кол-во:}1,0 \text{ (п/к) № - 1}$

Перевязки № - 1

Подготовка к операции, очистительная клизма № - 1

режим стационарный, диета №15 № - 8

Инфузионно-трансфузионная программа:

Дата и время - 17.08.2021 11:32, Препараты - NaCl $0,9\%$, Доза(мл) - $200,0$, В составе раствора - , Н/фл - , Скорость (мл/ч) - , Перелито (мл) -

Дыхательная гимнастика 2

Магнитотерапия 1

Ингаляция 1

Состояние при выписке: Совместный осмотр с зав. отд. Абдалиевым С.С.

Общее состояние удовлетворительное. Жалобы на умеренные боли в области оперативного вмешательства.

Температура тела в норме. Кожные покровы физиологической окраски, чистые. В легких дыхание проводится по всем полям, хрипов нет. ЧДД 19 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. ЧСС = 88 в' , АД $100/70 \text{ мм.рт.ст.}$ Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Диурез сохранен.

Локально: Пациент передвигается в груднопоясничном корсете. Повязка на послеоперационной ране фиксирована, сухая. Произведена смена асептической повязки. Послеоперационная рана без признаков воспаления, заживает первичным натяжением, швы состоятельны. На периферий сосудистых и неврологических расстройств нет.

Курс лечения закончен, пациент с улучшением выписывается для дальнейшего амбулаторного лечения и наблюдения. Даны рекомендации.

Емдік және еңбек ұсынымдары (Лечебные и трудовые рекомендации): 1. Наблюдение травматолога – ортопеда, педиатра по месту жительства.

2. Ограничение физических нагрузок.

3. Ношение корсета

4. Санаторно-курортное лечение.

5. Продолжить курс ЛГ, ЛФК, ФТЛ по месту жительства в поликлинике.

6. Реабилитационное лечение через 2-3 месяца после операции!

7. Консервативное лечение 2 раза в год амбулаторно по месту жительства.

8. Профилактика травматизма, избегать переохлаждения.

9. Консультация вертебролога, контрольная рентгенография через 6 месяцев для наблюдения динамики

Лечащий врач:

ЩЕРБИНА АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Заведующий отделением:

АБДАЛИЕВ СЕИД АЛИ САПАРБАЕВИЧ

Подпись пациента

